

PCIMNE — Prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant

Diapositive 1

Informations

sur les Auteurs (

Titre

, Nom,

Diplôme

etc.)

TITRE DU COURS

Filière, Année d'étude, Semestre etc.

Diapositive 2

GENERALITES SUR LA PCIMNE

OUATTARA AISSA EPOUSE KOUADIO

Diapositive 3

INTRODUCTION (1/2)

Constat du taux élevé de la mortalité chez les moins de 5 ans;

70% des décès chez l'enfant de moins de 5 ans :

affections néonatales

Paludisme

Infections respiratoires aigue

Diarrhée

Rougeole

VIH /Sida

malnutrition

Diapositive 4

INTRODUCTION (2/2)

Stratégie née à la conférence mondiale de l'enfance à New York en 1990;

Constat du taux élevé de la mortalité chez les moins de 5 ans;

OMS et UNICEF responsabilisés pour proposer des approches pour réduire de 50 % le taux de la

mortalité à l'an 2000

figure dans les Objectifs Du Millénaire (ODM) la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans;

Diapositive 5

OBJECTIF GENERAL

Ce cours vise à faire connaître la PCIMNE

Diapositive 6

OBJECTIFS SPECIFIQUES(1/2)

A la fin de la séance , vous devez être capable de :

Donner la définition de la PCIMNE selon le cours

Citer toutes les maladies cibles de la PCIMNE

Enumérer toutes les stratégies de la PCIMNE

Décrire l'objectif de la PCIMNE en s'appuyant sur les trois composantes

Diapositive 7

OBJECTIFS SPECIFIQUES(2/2)

5. Citer tous les principes de la PCIMNE
6. Citer les cinq signes généraux de dangers
7. Décrire les trois fiches de prise en charge
8. Décrire la procédure de la prise en charge de l'enfant malade

Diapositive 8

PLAN DU COURS

Historique de la PCIMNE

Définition du sigle PCIMNE

Concept de la PCIMNE

Objectifs de la PCIMNE

Justification la PCIMNE

Principes de base de la PCIMNE

Diapositive 9

DÉFINITION DU SIGLE PCIMNE

P

rise en

C

harge

I

ntégrée des

M

aladies

N

ouveau-né et de l'

E

nfant;

Diapositive 10

CONCEPT

Diapositive 11

STRATÉGIE(1/3)

Est une stratégie qui :

Focaliser sur les enfants de la
tranche d 'âge

0-5ans;

Diapositive 12

STRATÉGIE (2/3)

Est une stratégie qui :

Intègre les interventions
curatives

,

préventives

et

promotionnelles

;

Intervient au niveau des formations sanitaires, et au niveau des familles et des communautés;

Diapositive 13

STRATÉGIE (3/3)

7 principales causes de mortalité

:

Affections néonatales graves

Paludisme;

IRA;

Diarrhée;

Rougeole;

Malnutrition;

VIH/SIDA

Diapositive 14

OBJECTIF

(1/7)

Contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité des enfants de <5 ans en s'appuyant sur 3 composantes:

Composante N°1:

amélioration des compétences des agents de santé

Composante N°2:

renforcement du système de santé

Composante N°3:

promotion des Pratiques Familiales Essentielles dans les familles et communautés

Diapositive 15

COMPOSANTES DE LA PCIMNE

CS

Pratiques familiales et
communautaires

Compétences du
personnel

Système de santé

Domicile

Domicile

1

2

3

Hôpital général

CS

Diapositive 16

12 Pratiques

Familiales

Essentielles

GROUPE 1: promotion de la croissance et du développement du nouveau-né et de l'enfant

La mère, le père ou la personne à charge de l'enfant prend en charge le nouveau-né;

Allaite exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois;

OBJECTIF

(2/7)

Diapositive 17

12 Pratiques

Familiales

Essentielles

GROUPE 1

à partir de l'âge de 6 mois aliments de complément équilibrés

en continuant à l'allaiter jusqu'à 24 mois;

Tous les 6 mois , supplémentation en vitamine A de l'enfant âgé de 6 à 59 mois et déparasitage à partir de 12 mois;

Consomment tous les jours du sel iodé dans l'alimentation des ménages;

OBJECTIF

(3/7)

Diapositive 18

OBJECTIF

(4/7)

12 Pratiques

Familiales

Essentielles

GROUPE 2: PREVENTION DES MALADIES

Vacciner complètement l'enfant avant l'âge de 1 an;

Se laver les mains avec de l'eau propre et du savon et observe les bonnes pratiques d'hygiène du milieu: avant de préparer les repas des enfants , de nourrir les enfants et après avoir éliminé correctement les selles des enfants;

Les gestantes et les enfants de 0 à 5 ans doivent dormir toutes les nuits sous moustiquaire imprégnée d'insecticide à longue durée d'action (

MILDA

);

Diapositive 19

OBJECTIF

(5/7)

12 Pratiques Familiales Essentielles

GROUPE 3: PRISE EN CHARGE DES CAS A DOMICILE

Donner à l'enfant le traitement adéquat à domicile:

De la diarrhée

De la fièvre et du paludisme

Des infections respiratoires aiguës

Diapositive 20

OBJECTIF

(6/7)

12 Pratiques Familiales Essentielles

GROUPE 4: RECHERCHE DES SOINS AU CENTRE DE SANTE

Reconnaitre les signes de danger et de gravité afin de l'emmener à temps chez le prestataire qualifié au centre de santé pour recevoir les soins appropriés;

Diapositive 21

12 Pratiques

Familiales

Essentielles

GROUPE 4: RECHERCHE DES SOINS AU CENTRE DE SANTE

La femme enceinte se fait suivre en CPN recentrée et accouche sous la surveillance d'un personnel qualifié;

La mère et l'enfant se font suivre après l'accouchement par un personnel qualifié;

OBJECTIF

(7/7)

Diapositive 22

JUSTIFICATION

22

30/06/2026

22

Diapositive 23

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1 – 2%

20 – 50%

50 – 80%

Hôpital

général

Centre de santé

Ménage

23

30/06/2026

23

Les lieux de décès de ces enfants sont connus

Diapositive 24

PRINCIPES

Destinée aux agents de santé des ESPC;

Approche syndromique;

Approche systématique;

Utilisation des signes spécifiques pour la classification de la maladie;

Approche rationnelle pour le traitement (choisir le traitement et traiter l'enfant);

Conseiller la mère;

Organiser la continuité des soins (suivi);

Diapositive 25

SIGNES GENERAUX DE DANGERS

Cinq signes généraux

de dangers:

L'enfant vomit tout ce qu'il boit ou tout ce qu'il consomme;

L'enfant est incapable de boire ou de prendre le sein;

L'enfant a eu des antécédents de convulsions

L'enfant a des convulsions actuelles;

L'enfant est léthargique ou inconscient;

Diapositive 26

FICHES DE PRISE EN CHARGE

La fiche des nouveaux nés de

0 à 1 semaine;

la fiche des enfants d'

1 semaine à 2 mois;

la fiche des enfants de

2 mois à 5 ans;

Diapositive 27

DIFFERENTES BANDES DE LA PCIMNE

Rose

Jaune

Vert

Référence d'urgence

Après les 1ers soins

Traitement spécifique

Prise en charge à domicile

Diapositive 28

PROCEDURE DE LA PRISE EN CHARGE DE L'ENFANT MALADE

1. Evaluer l'enfant malade
2. Classer la maladie de l'enfant
3. Choisir ou identifier le traitement
4. Traiter l'enfant
5. Conseiller la mère
6. Assurer le suivi de l'enfant malade

Diapositive 29

1. Evaluer l'enfant malade

Rechercher les signes de danger

Demander

:

Si l'enfant tousse ou a des difficultés respiratoires

L'enfant a-t il la diarrhée?

L'enfant a-t il la fièvre

L'enfant a-t il un problème d'oreille

Ensuite

:

Vérifier l'état nutritionnel et rechercher

l'anémie

Ensuite

Vérifier l'état vaccinal de l'enfant

Ensuite

:

demander s'il y a d'autres problèmes

Pour toute réponse "oui"

Poser

d'autres

questions

Regarder, écouter

et palper

Signes

Classer la maladie

Choisir le traitement

Demander à la mère quels sont les problèmes de l'enfant

Traiter l'enfant

Conseiller la mère

Suivre l'enfant malade

Diapositive 30

2. Classer la (les) maladie(s)

REFERER

Traiter au CS et conseiller

la mère

Conseiller pour les soins à

domicile

SIGNES

Classifications possibles:

Diapositive 31

3. Choisir le Traitement

Identifier le traitement requis pour chaque classification;

Choisir le traitement qui correspond à plus d'une classification;

Attention: respecter les principes suivants:

Rationalisation

Amélioration de l'accessibilité financière

Efficacité

Diapositive 32

4. Traiter l'enfant

REFERER

Donner la première dose conseiller la mère

Traiter au CS

Enseigner la mère comment

donner les médicaments

oraux. Conseiller la mère

Enseigner la mère comment donner les médicaments et identifier les signes de danger et quand revenir.

les soins à

domicile

Selon la classification

Diapositive 33

CONSEILLER LA MÈRE

Enseigner comment donner les médicaments oraux et traiter les infections locales

Conseiller sur l'alimentation et l'allaitement maternel au sein

Conseiller de continuer à donner les liquides

Conseiller "quand revenir" au CS

Technique

: Demander, écouter, féliciter, conseiller, vérifier la compréhension et la compétence

Diapositive 34

APPRENDRE A LA MERE COMMENT ADMINISTRER DES MEDICAMENTS PAR VOIE ORALE A DOMICILE

Expliquer comment et pourquoi le traitement est administré;

Observer la mère pendant qu'elle donne le premier traitement au centre de santé;

Expliquer à la mère la fréquence d'administration des médicaments;

Dire à la mère qu'elle doit revenir au centre de santé si l'infection s'aggrave;

Diapositive 35

APPRENDRE A LA MERE COMMENT ADMINISTRER DES MEDICAMENTS PAR VOIE ORALE A DOMICILE

Déterminer les médicaments et doses appropriés selon l'âge ou le poids de l'enfant

Expliquer à la mère pourquoi l'enfant a besoin du médicament

Montrer comment mesurer une dose

Observer la mère pendant qu'elle mesure une dose

Demander à la mère de donner la 1

ère

dose à l'enfant

Diapositive 36

APPRENDRE A LA MERE COMMENT ADMINISTRER DES MEDICAMENTS PAR VOIE ORALE A DOMICILE (suite)

Expliquer en détails comment donner le médicament dans un sachet ou un cornet et inscrire le nom du médicament sur le sachet ou le cornet;

Si plusieurs médicaments sont donnés ; rassembler ,compter et mettre chaque médicament dans chaque cornet différent

Diapositive 37

APPRENDRE A LA MERE COMMENT ADMINISTRER DES MEDICAMENTS PAR VOIE ORALE A DOMICILE (suite)

Expliquer que tous les médicaments (comprimés ou sirops) doivent être pris jusqu'à la fin du traitement , même si l'enfant se porte mieux

S'assurer que la mère a bien compris avant qu'elle ne quitte le dispensaire

Diapositive 38

UN PÈRE ENTHOUSIASTE DE LA NOUVELLE STRATÉGIE DE PRISE EN CHARGE: PCIMNE

Diapositive 39

Merci beaucoup